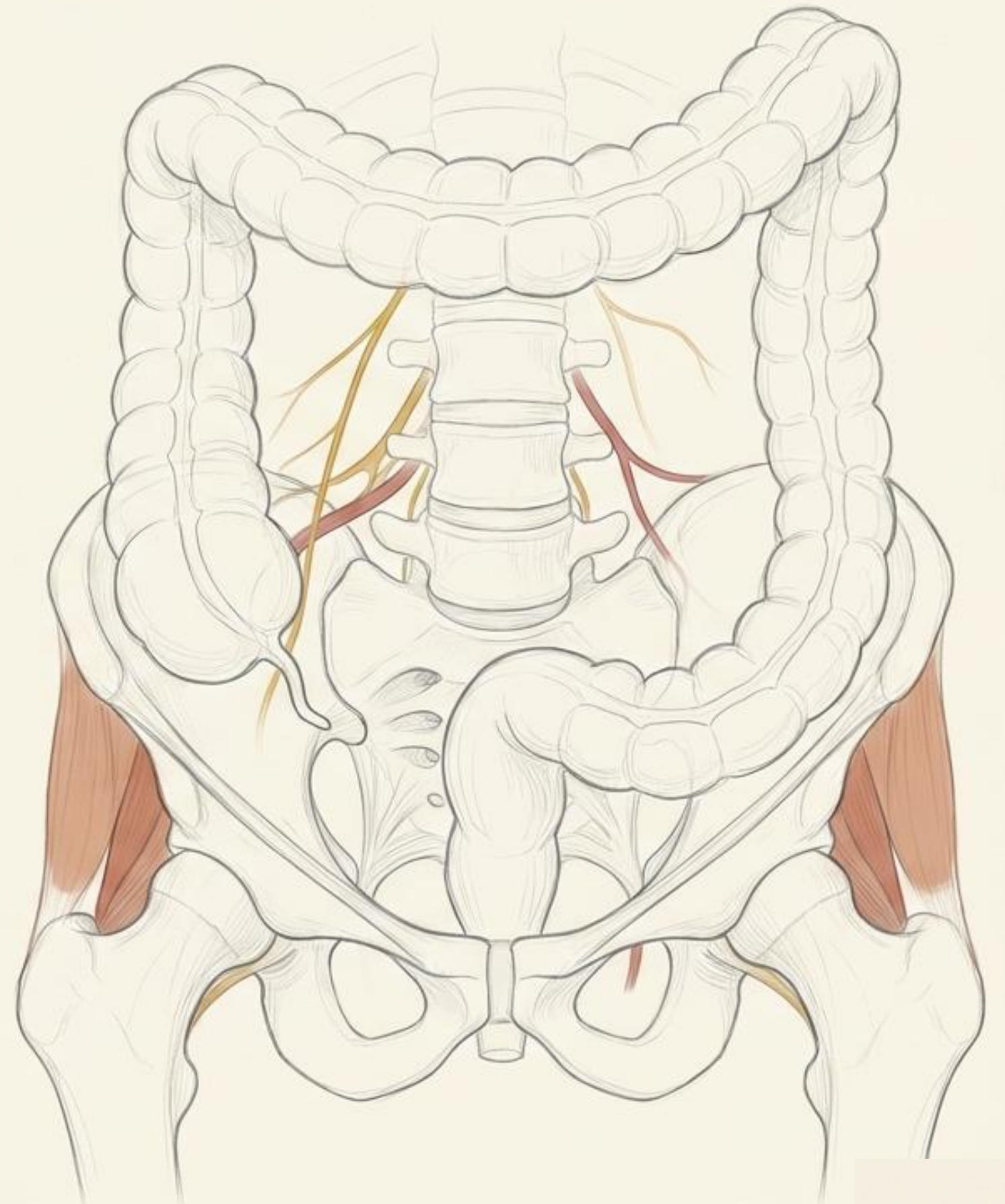


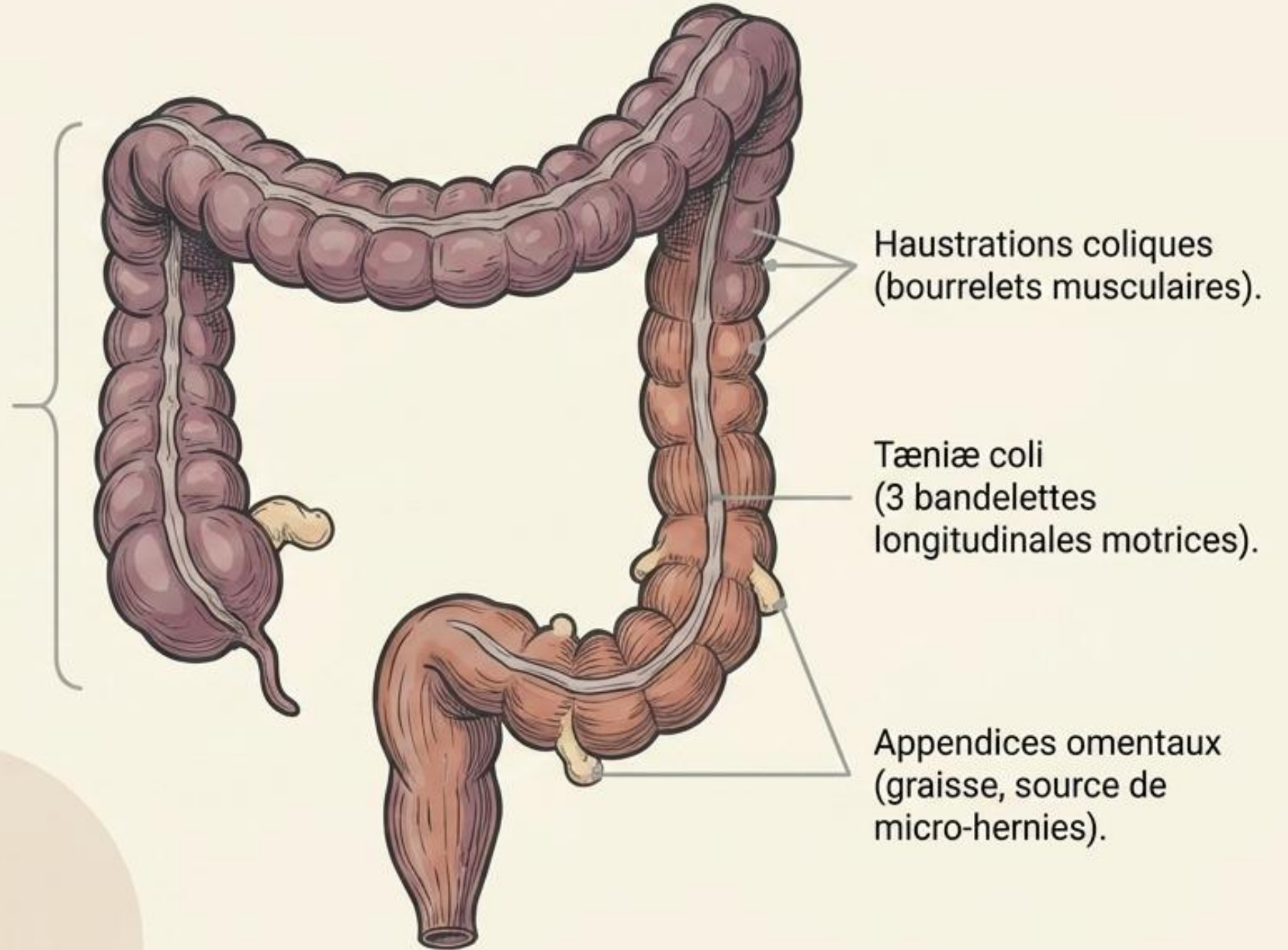
Côlon et Rectum

Anatomie fonctionnelle, physiologie
et applications cliniques en ROP.



L'Architecture du Cadre Colique

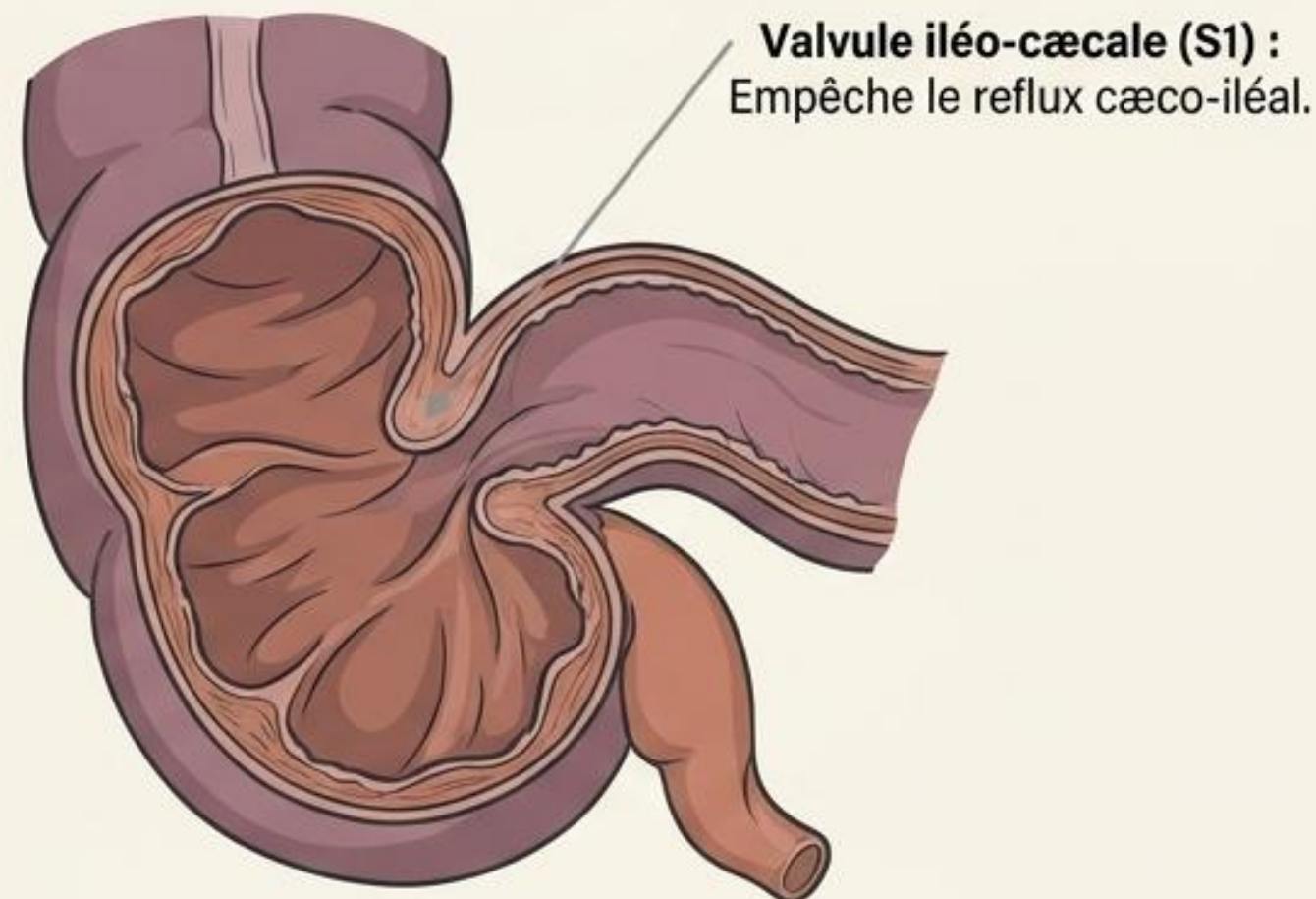
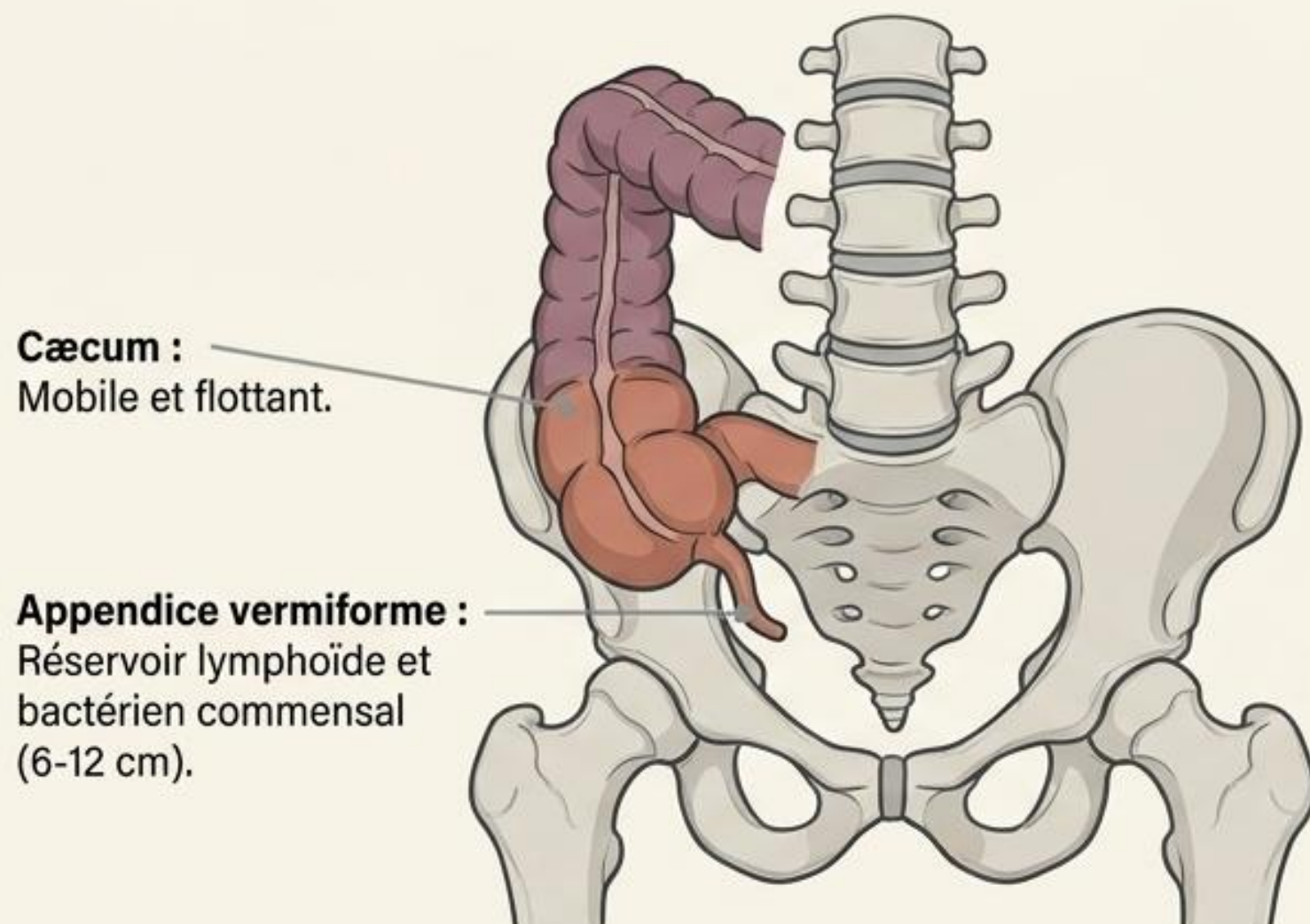
1,50 m de longueur
(encadre l'intestin grêle).



Fonction primaire

Absence de villosités. Réabsorption d'eau
(jusqu'à 1,5L/jour) et d'électrolytes.
Transformation du chyme liquide en fèces solides.

L'Origine : Cæcum et Jonction Iléo-cæcale



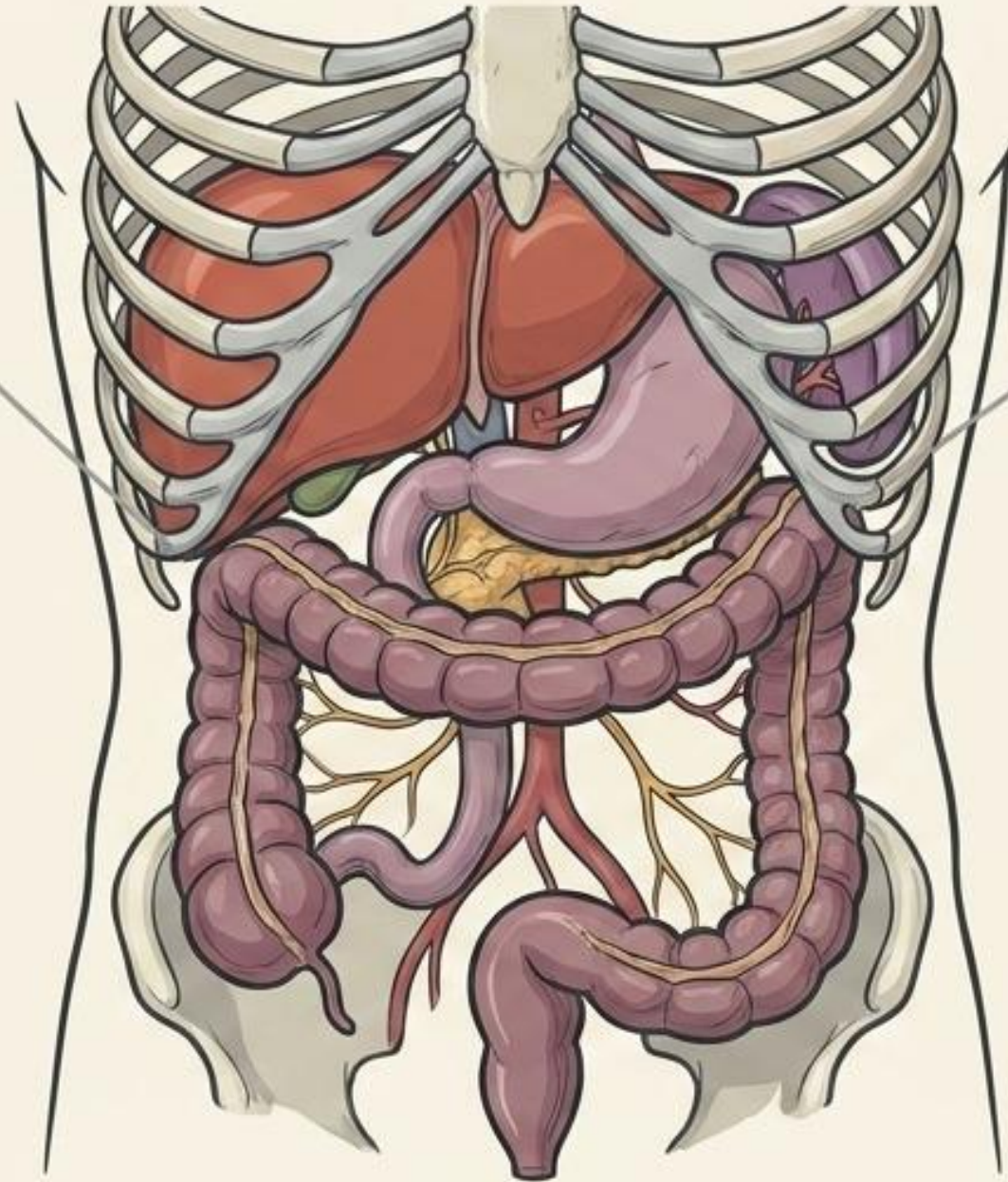
Intérêt en ROP : Conséquences d'une appendicectomie

- Perte de mobilité cæcale (adhérences).
- Fixation de la sacro-iliaque droite.
- Lombo-sciatalgie droite sans traumatisme.
- Perte de mobilité de l'ovaire droit (ligament appendico-ovarien).

L'Ascension et le Travers : Les Angles Coliques

Angle Hépatique (Droit)

- Fermé (70-80°).
- Fixe, sous le lobe droit du foie (8e côte).
- **Rapports** : Foie, vésicule biliaire, rein droit.

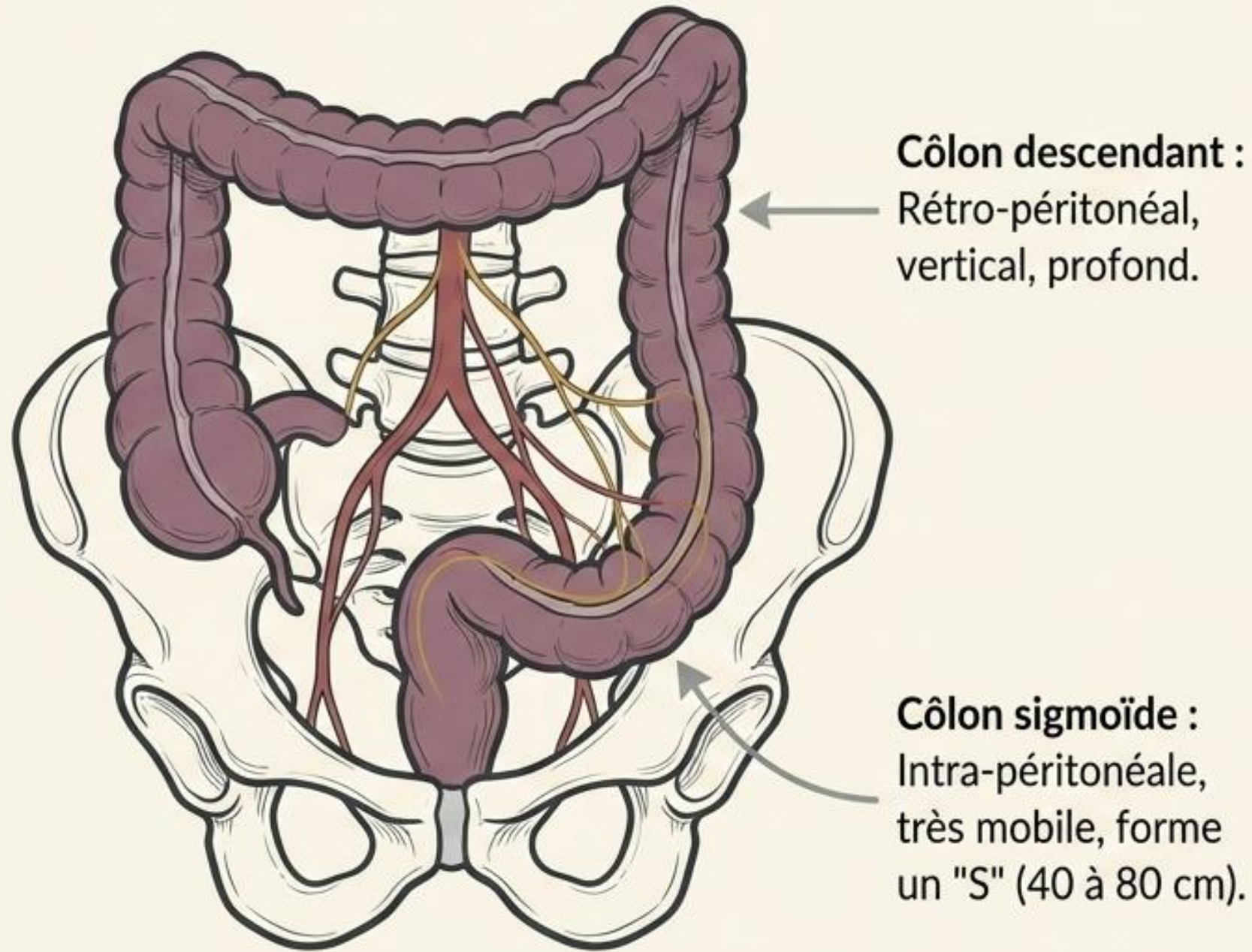


Angle Splénique (Gauche)

- Aigu (50°), situé plus haut (Th11).
- Très mobile, soutient la rate.
- **Rapports** : Estomac, queue du pancréas, rein gauche.

Le Mésocôlon Transverse : Sépare la cavité abdominale en deux étages. Son riche réseau neuro-vasculaire le rend hautement réflexogène en ROP.

La Descente et la Boucle Sigmoidienne



Intérêt en ROP : Le Mésosigmoïde et ses Racines

- **Racine Principale** : Verticale (S3). Contient le plexus hypogastrique supérieur.
- **Racine Secondaire** : Oblique. Contient l'artère mésentérique inférieure. Longe le bord médial du psoas.
- **Note Clinique** : Les adhérences du sigmoïde créent une tension sur le grand psoas gauche, favorisant l'apparition de lombo-sciatalgies gauches.

Le Carrefour Pelvien : Rectum et Canal Anal

Loge rectale : Partie la plus postérieure de la cavité pelvienne.



Rapports antérieurs : Cul-de-sac de Douglas, utérus/vagin.

Ampoule rectale : Segment pelvien (15 cm), suit la courbure du sacrum. Stockage.

Courbure périnéale : Angle de 90° maintenu par le faisceau puborectal.

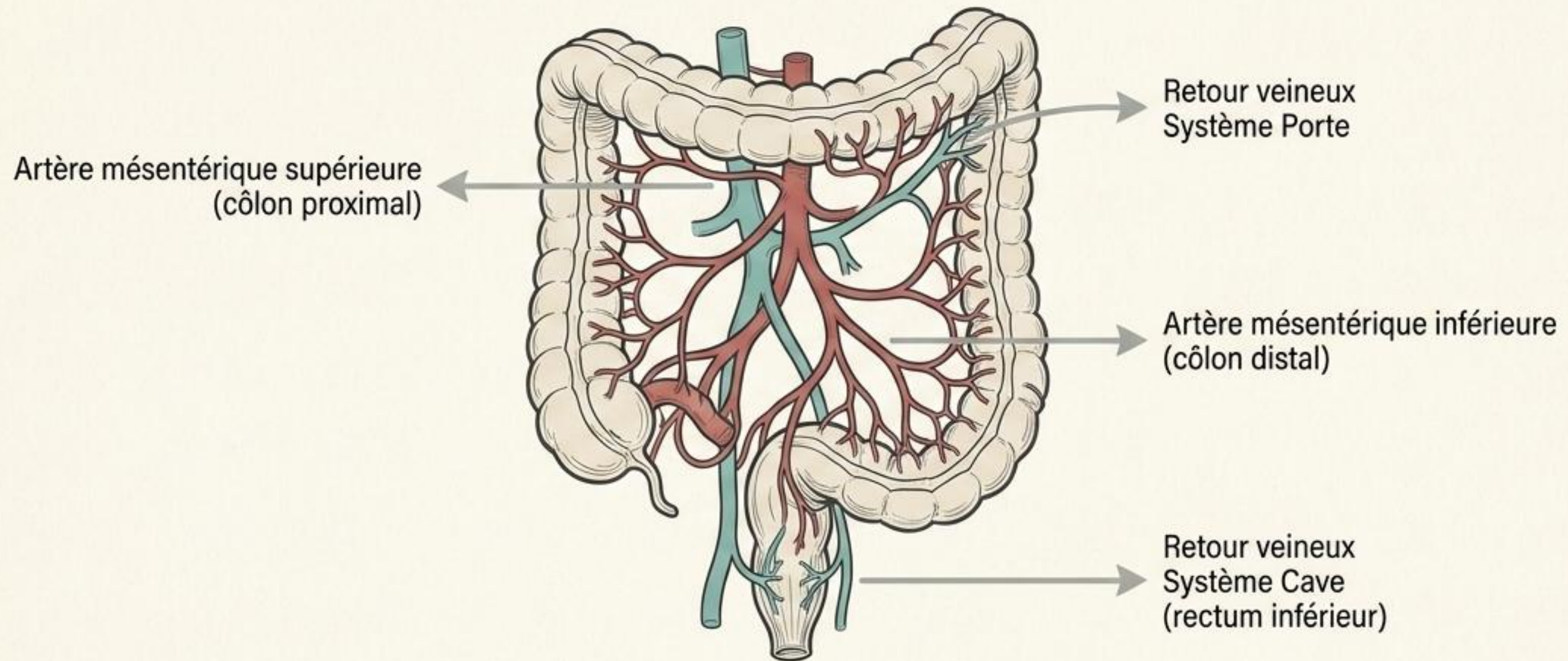
Canal anal : Segment périnéal (4 cm), traverse le diaphragme pelvien.

Matrice Fonctionnelle : Le Contrôle Anorectal

Sphincter Interne	Sphincter Externe
Nature : Fibres musculaires lisses	Nature : Anneau de muscles striés
Contrôle : Inconscient (SNA)	Contrôle : Volontaire (Système nerveux somatique)
Innervation : Parasympathique pelvien & Sympathique (Th12-L1)	Innervation : Nerf pudendal
Fonction : Assure la continence de base, maintient le stockage	Fonction : Ultime obstacle, contrôle volontaire de la défécation

L'inhibition répétée du réflexe de défécation volontaire désensibilise les mécanorécepteurs rectaux et conduit à la constipation chronique.

Irrigation Vasculaire et Conséquences



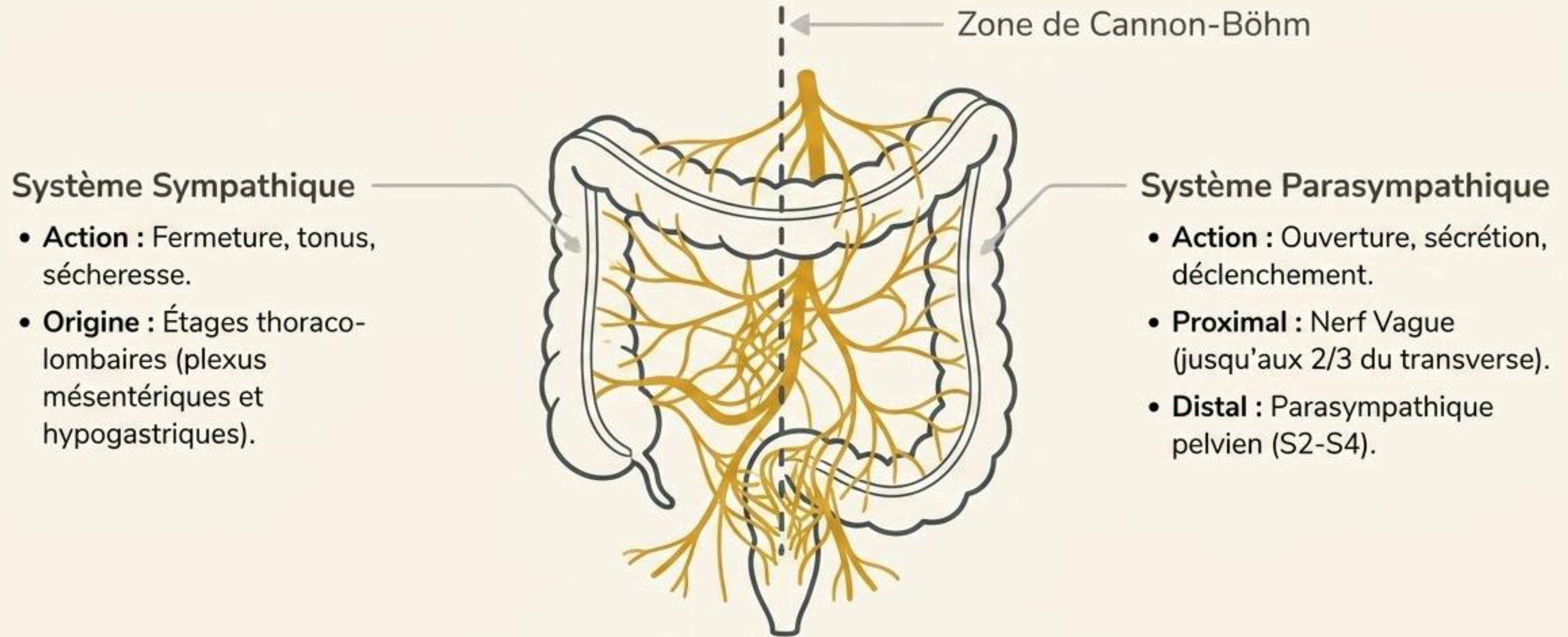
Hypertension Portale

La congestion hépatique crée des varices rectales (distinctes des hémorroïdes de poussée). Le rectum appartient à la fois au système digestif, veineux et pelvien.

Stase Veineuse ROP (Système vertébro-discal)

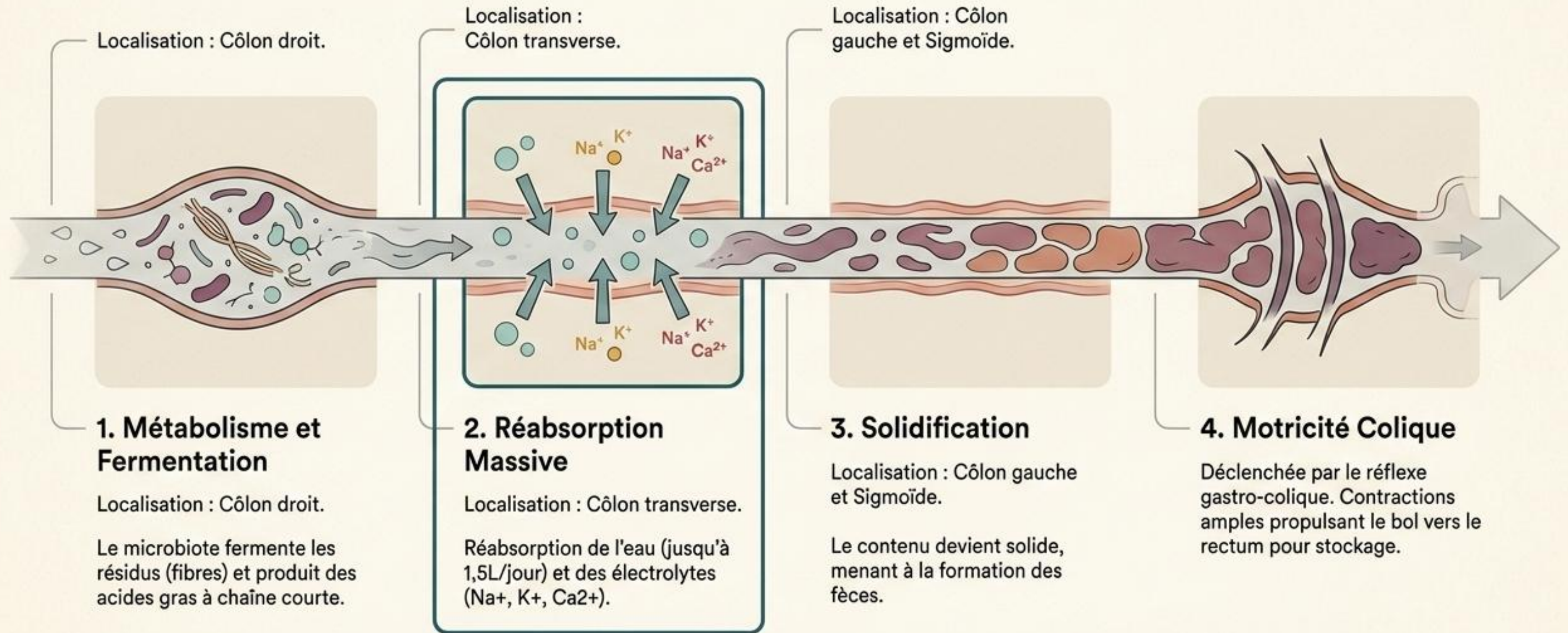
La congestion des veines lombales diminue l'imbibition aqueuse et la visco-élasticité des disques intervertébraux, favorisant la lombosciatalgie gauche. Vérifier le rein et la veine rénale gauche.

Câblage Neurologique Autonome



Intérêt en ROP : La Zone de Cannon-Böhm est le carrefour vasculo-nerveux majeur. En colopathie, la peau de cette zone est indurée et sensible.

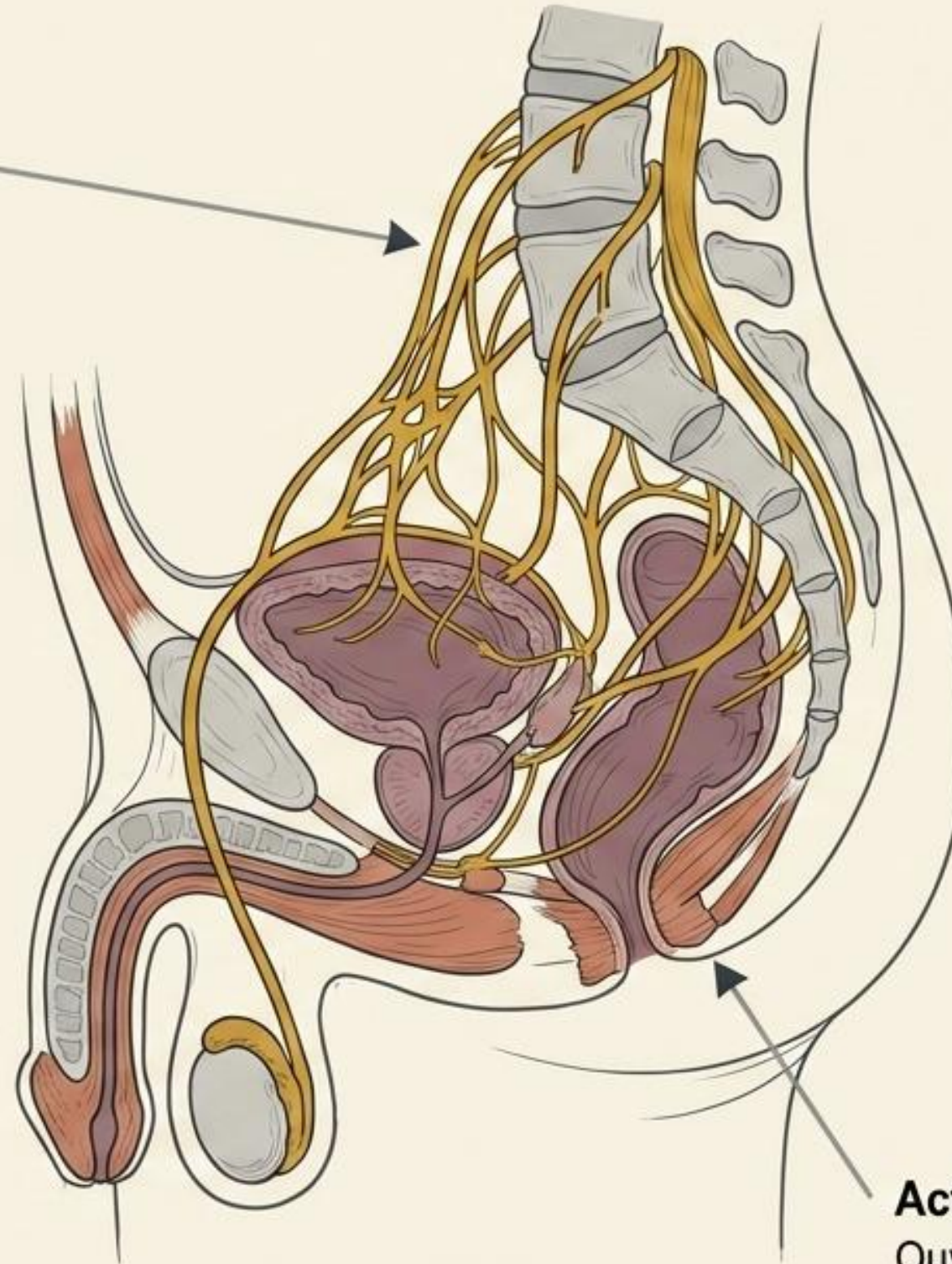
Physiologie : Motricité et Absorption



Le Câblage Autonome : Innervation et Réflexes

Action Sympathique (Th-L)

Fermeture des sphincters, tonus, relative sécheresse de la muqueuse.



La Zone de Cannon-Böhm

- **Quoi ?** Un carrefour vasculo-nerveux majeur.
- **Où ?** Transition entre le Nerf Vague (proximal) et le Parasympathique pelvien (distal).
- **Clinique ROP** : Zone cutanée souvent indurée lors de colopathies. Point réflexe primordial.

Action Parasympathique (S2-S4)

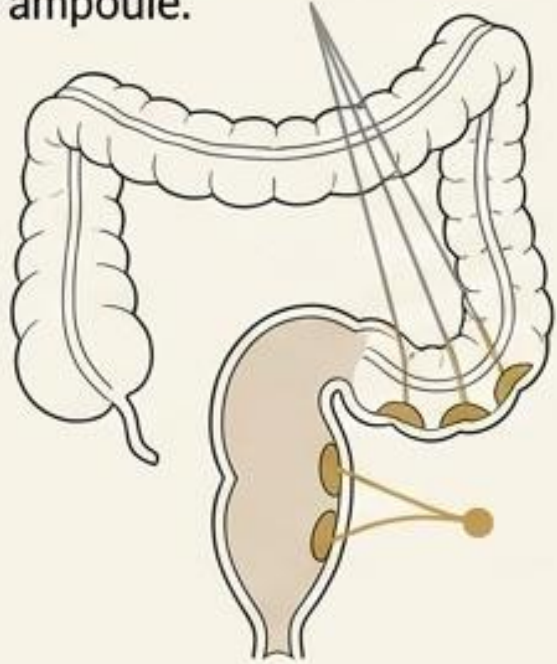
Ouverture, sécrétion, déclenchement du péristaltisme.

Mécanique de la Défécation

Phase Inconsciente

1. Dilatation

La pression intra-rectale augmente, stimulant les mécanorécepteurs de l'ampoule.



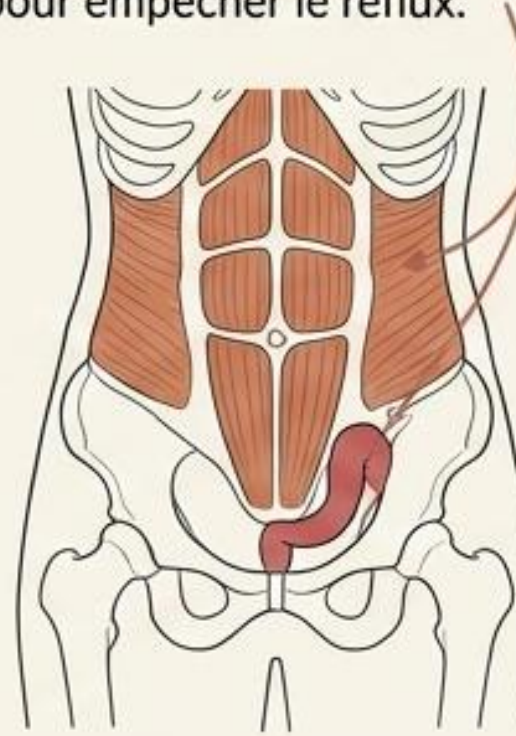
2. Alerte Neurologique

Les nerfs afférents informent le Thalamus et le Cortex, générant l'envie consciente.



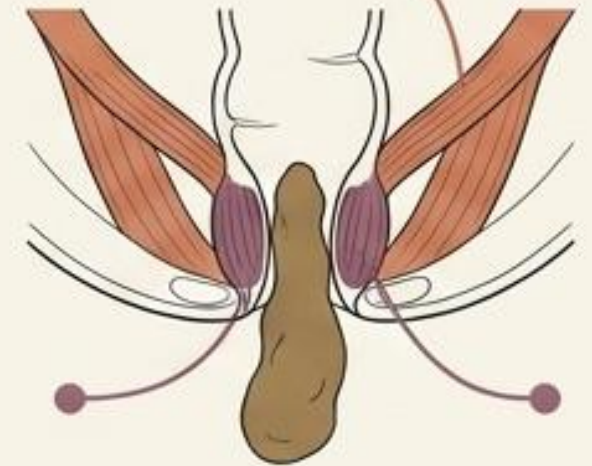
3. Préparation Mécanique

Contraction abdominale et fermeture recto-sigmoïdienne pour empêcher le reflux.



4. Exonération

Relâchement du releveur de l'anus, ouverture de l'angle anorectal à $>90^\circ$, et relâchement du sphincter externe.



Attention Clinique : L'inhibition répétée du besoin d'aller à la selle (se retenir) détruit progressivement la boucle réflexe neurologique, menant à une atonie colique irréversible et à la formation de fécalomes.

Clinique : Constipation et Colopathies

Constipation Proximale (Droite)	Constipation Distale (Gauche)
Stase caecale. Création de toxines générant céphalées, dyspepsie et mauvaise haleine. Fosse iliaque droite très sensible.	Origine mécanique. Stagnation dans le sigmoïde ou l'ampoule rectale. Souvent mieux supportée cliniquement.

Complications Mécaniques

Fécalome

Perte de stimulation des mécanorécepteurs rectaux par stagnation sévère.

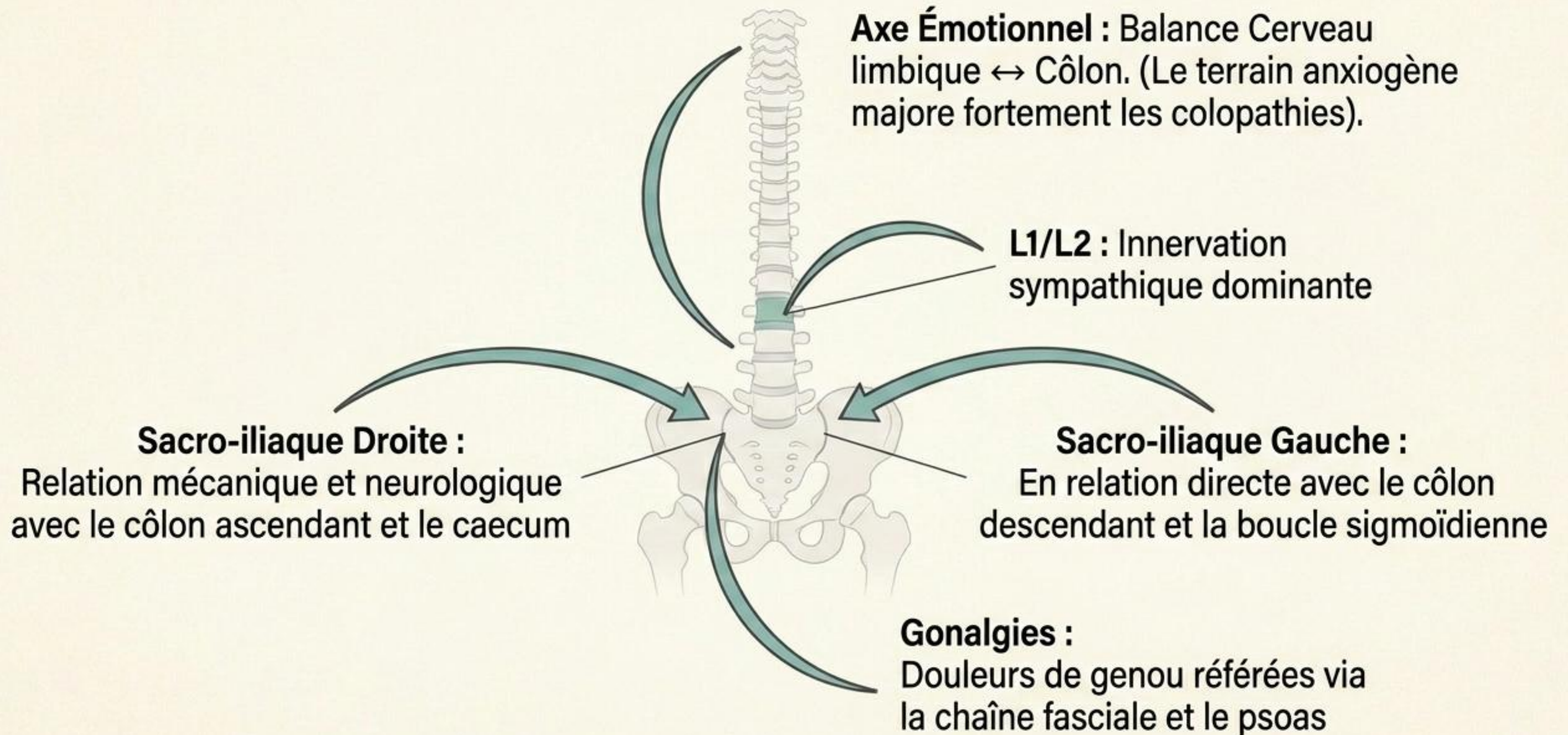
Thrombose hémorroïdaire

Tension rectale bloquant le retour veineux.

Colopathies Fonctionnelles (Syndrome de l'intestin irritable)

Trouble de l'axe intestin-cerveau provoquant hypersensibilité viscérale, spasmes modifiant la vascularisation locale, et transit alternant (sans lésion organique).

Synthèse Viscéro-Somatique



Cartographie ROP : Système Nerveux, Limbique et Microbiote



- **Nerf Vague (X)** : Modulation parasympathique crânienne.
- **Parasympathique Pelvien** : Relance de l'ouverture et motricité basse.
- **Chaîne Ganglionnaire (Th9-Th12)** : Sympathique, articulations costo-transversaires.
- **Plexus Hypogastrique Inférieur** : Canal sacré (S2-S4).

Balance Cerveau Limbique - Côlon

La prise en charge ROP nécessite une écoute-induction simultanée (pouce sur le côlon, pouce sur le cerveau limbique).
Le traitement mécanique doit s'accompagner d'une gestion du stress et d'une lutte contre la dysbiose (microbiote) par une hydratation adaptée et la réduction des sucres raffinés.

Cartographie Podale ROP

